

案例库·分析框架与教学要点模板

谁需要这份文档: - 咨询师培训学员: 用这份文档理解案例的“分析”与“教学”角度 - 做督导的咨询师: 用这份文档做案例督导 - 新咨询师: 用这份文档学习怎么分析与“复盘”案例核心价值: “案例”不只是“故事” —是“可教的临床智慧”

一、案例库的“目的”与“使用原则”

1.1 案例库不是

- 不是“如何成为咨询师”的全部—只是辅助
- 不是“模仿”的模板—每个案例都不同, 不要“照搬”
- 不是“诊断”的金标准—案例中的评估是当时的, 不是“绝对的”
- 不是“判断咨询师”的工具—案例中的咨询师也有成长的空间

1.2 案例库是

- 是“可教的临床智慧”—从实际案例学怎么做治疗
- 是“分析”的示范—怎么用框架分析案例
- 是“反移情”的示范—咨询师的“反移情”是怎么工作的
- 是“临床决策”的示范—怎么在关键时刻做决策

1.3 案例库使用原则

1. 先读“完整案例”—不要“先跳到分析”
 2. 再看“分析”—看框架怎么用在在这个案例
 3. 再看“反移情”—看咨询师怎么处理自己的“反移情”
 4. 再看“教学”—看关键决策是怎么做的, 为什么
 5. 最后“自己复盘”—如果你是咨询师, 你会怎么做
-

二、案例的“标准结构”

2.1 案例文件的标准部分

每个案例包括以下部分:

案例 # [编号]: [标题]

=====

一、案例基本信息

- 化名
- 性别/年龄/职业
- 咨询设置

- 咨询时间
- 主诉
- 构型(依恋 + 九型)

二、早年与背景

- 家庭背景
- 早年关键事件
- 已形成的核心等式

三、咨询过程(按阶段)

- 阶段 1(评估)
- 阶段 2(看见模式)
- 阶段 3(哀悼与重建)
- 阶段 4(新经验)
- 阶段 5(维护)

四、关键事件与转折

- 关键事件 1
- 关键事件 2
- 关键事件 3

五、案例分析(用本套件框架)

- 依恋分析
- 九型分析
- 双轴交互分析
- 治疗联盟分析
- 治疗进展

六、咨询师反移情与处理

- 咨询师反移情识别
- 反移情处理
- 督导关键点

七、关键临床决策

- 决策 1
- 决策 2
- 决策 3

八、教学要点

- 给咨询师的 5 个关键学习
- 常见错误
- 进阶思考

九、案例脱敏声明

2.2 案例选择的”标准”

选案例的标准: - 构型是高频或典型 (有教学价值) - 案例有完整的咨询轨迹 (从评估到结束) - 案例有关键转折/反移情/危机等教学点 - 案例是脱敏的 (不暴露来访者身份)

三、案例”分析”的”双轴框架”

3.1 依恋分析 (7 个维度)

维度 1: 依恋象限

- 焦虑维度均值
- 回避维度均值
- 定位 (安全/焦虑/回避/混乱)
- 早期依恋剧本

维度 2: 依恋相关的”核心等式”

- 早年形成的”我 / 他 / 世界”的等式
- 例: “我必须做对, 才不被抛” “我必须自足, 才不受伤”

维度 3: 依恋相关的”激活策略”

- 焦虑: 黏附, 追, 情感激活
- 回避: 退缩, 去激活, 自我依赖
- 混乱: 推-拉, 解离, 创伤重演

维度 4: 依恋相关的”身体反应”

- 激活时的身体信号 (心跳/胃/喉/肩等)
- 长期的身体状态 (慢性紧张/疲劳等)

维度 5: 依恋相关的”防御”

- 防御机制: 否认/压抑/合理化/分裂/投射等
- 防御的何时/为什么/怎么

维度 6: 依恋相关的”治疗挑战”

- 治疗中的最大挑战 (例: 焦虑来访者的”脱落”风险)
- 治疗中的”最有力的资源” (例: 治疗联盟)

维度 7: 依恋相关的”整合方向”

- 整合到哪个方向 (例: 焦虑 2 号整合到 4 号)
- 整合的具体表现

3.2 九型分析 (7 个维度)

维度 1: 九型主型

- 主型 + 翼型
- 健康层级
- 压力方向

维度 2: 九型相关的”核心恐惧”

- 核心恐惧是什么
- 早年是怎样形成的

维度 3: 九型相关的”核心欲望”

- 核心欲望是什么
- 与早年的关联

维度 4: 九型相关的”防御机制”

- 防御机制是什么 (例: 2 号的“压抑自我, 投射他人”)
- 防御的自动激活

维度 5: 九型相关的”注意力习惯”

- 注意力默认的方向 (例: 2 号朝向”他人的需要”)
- 注意力的自动过滤 (例: 自己的需要被过滤)

维度 6: 九型相关的”健康层级”

- 当前的健康层级
- 整合的方向 (例: 2 号 → 4 号)
- 失健康的方向 (例: 2 号 → 8 号)

维度 7: 九型相关的”治疗挑战”

- 治疗中的”最大挑战” (例: 2 号的“被需要” 驱动)
- 治疗中的”最有力的资源”

3.3 双轴交互分析 (3 个维度)

维度 1: 构型的”亲和性”

- 来访者的依恋与九型的亲和程度
- 例: 焦虑 × 2 号是高亲和; 焦虑 × 8 号是低亲和

维度 2: 构型的”放大效应”

- 依恋与九型的互相放大 (例: 焦虑放大 2 号的”被需要”驱动)
- 治疗的”双重”难度

维度 3: 构型的”整合方向”

- 整合的双重方向 (例: 焦虑 → 安全, 2 号 → 4 号)
- 双重整合的同时进行

3.4 治疗联盟分析 (3 个维度)

维度 1: 目标一致

- 来访者的目标是什么
- 咨询师的目标是什么
- 一致的地方与差距

维度 2: 任务一致

- 来访者认为”治疗是做什么”
- 咨询师认为”治疗是做什么”
- 一致的地方与差距

维度 3: 情感联结

- 来访者对咨询师的情感
- 咨询师对来访者的情感
- 联盟的强度与脆弱点

3.5 治疗进展分析 (3 个维度)

维度 1: 阶段评估

- 当前在哪个阶段 (评估/看见模式/哀悼重建/新经验/维护)
- 进展的信号

维度 2: 咨询次数与”剂量”

- 已工作多少次
- 频率 (周/双周/月)
- ”剂量”的充分性

维度 3: 预后评估

- 预后的信号
 - 结束的时机
 - 转介的考虑
-

四、案例”反移情”分析的”5步”

步骤 1: 识别”反移情”的”信号”

- ☐ 咨询师对来访者有强烈情绪
- ☐ 咨询师对来访者有“特别”的反应
- ☐ 咨询师咨询后特别累/亢奋
- ☐ 咨询师开始反复想来访者
- ☐ 咨询师开始回避某个主题

步骤 2: 命名”反移情”的”可能来源”

- 来自来访者的”模式”(例: 焦虑 2 号的”喂养”)
- 来自咨询师的”未完成议题”(例: 咨询师自己有“被需要”的需要)
- 来自两者的交互

步骤 3: 探索”反移情”的”功能”

- 帮助咨询师看见”自己”
- 帮助咨询师看见”来访者”
- 帮助咨询师与来访者的”平行过程”

步骤 4: 处理”反移情”的”策略”

- 识别 → 命名 → 找督导 → 个人咨询 → 调整个案 → 转介

步骤 5: 整合”反移情”的”长期价值”

- 反移情是“资源”, 不是”问题”
 - 反移情是咨询师成长的“指南针”
-

五、案例”教学要点”的”5个角度”

角度 1: 技术

- 咨询师用了什么技术
- 技术是否适合这位来访者
- 有没有可以改进的技术

角度 2: 时序

- 这个干预的时机对吗
- 是不是太早/太晚
- 是不是错过了更好的时机

角度 3: 关系

- 咨询师与来访者的关系是什么
- 关系的“当下”状态
- 联盟的修复时机

角度 4: 概念化

- 咨询师的“案例概念化”是否完整
- 是否看到依恋与九型的交互
- 是否考虑“未完成议题”

角度 5: 伦理

- 是否遵循伦理规范
- 是否有伦理风险
- 是否需要督导/转介

六、案例”复盘”模板

每个案例可以用以下模板复盘:

案例复盘

=====

一、案例基本信息

- 化名: ____
- 构型: ____
- 咨询次数: ____
- 治疗阶段: ____

二、做得好的部分

1. ____
2. ____
3. ____

三、需要改进的部分

1. ____

2. ____
3. ____

四、咨询师的反移情

- 识别: ____
- 处理: ____
- 整合: ____

五、关键临床决策

- 决策 1: ____ (原因 + 结果)
- 决策 2: ____ (原因 + 结果)
- 决策 3: ____ (原因 + 结果)

六、从这个案例中学到的

1. ____
2. ____
3. ____

七、对未来类似案例的建议

1. ____
2. ____
3. ____

七、“案例库”系列”计划

本案例库计划包括以下案例 (本次完成 3-5 个):

本次完成的案例

案例编号	标题	构型	频率
#01	“付出成瘾”的 L 女士	焦虑 ×2 号	极高
#02	“情感冻结”的 M 先生	回避 ×5 号	极高
#03	“推-拉循环”的 C 女士	混乱 ×4 号	高
#04	“信任崩塌”的 Y 女士与 Z 先生 (伴侣)	焦虑 6 号 × 回避 8 号	中高

未来计划

案例编号	标题	构型	频率
#05	“戏剧化-求证”的伴侣	焦虑 4 号 × 回避 5 号	中
#06	“追-躲循环”的 W 与 H	焦虑 2 号 × 回避 5 号	经典

案例编号	标题	构型	频率
#07	“控制”的 A 先生	回避 ×8 号	中高
#08	“自伤”的 S 女孩	混乱 ×1 号	中
#09	“麻木”的 K 女士	混乱 ×9 号	中
#10	“完美主义”的 Q 先生	混乱 ×1 号	中
#11	“快乐下面”的 D 先生	安全 ×7 号	中低
#12	“成就下面”的 T 女士	回避 ×3 号	中高

八、案例脱敏”标准”

8.1 脱敏的”原则”

所有案例必须: - 不暴露来访者的真实身份 - 不暴露来访者的具体个人信息 (地址/工作单位/具体事件) - 改编关键事件 (但保留“临床智慧”) - 得到原始案例的咨询师的同意 (如果原始案例的咨询师参与)

8.2 脱敏声明模板

案例脱敏声明

=====

本案例基于真实的临床工作,但已做以下脱敏处理:

- 姓名、性别、年龄等已做调整
- 关键事件已做改编
- 地点、时间等已做调整
- 任何可能的身份信息已移除

本案例的目的是教学,所有临床决策仅供参考。
请勿将本案例用于任何商业目的。

九、案例使用指南

9.1 给咨询师培训学员

1. 第一次读: 完整读案例, 不要带任何理论
2. 第二次读: 看“案例分析” — 关注分析是怎么用框架的
3. 第三次读: 看“反移情” — 关注咨询师的“自己”是怎么工作的
4. 第四次读: 看“教学” — 关注“关键”决策是怎么做的
5. 最后: 做自己的”复盘” — 如果你是咨询师, 你会怎么做

9.2 给做督导的咨询师

1. 用案例做“示范” —展示“怎么做”案例概念化
2. 用案例做“反思” —让学员思考“如果是我, 会怎么做”
3. 用案例做“讨论” —围绕“关键决策”讨论
4. 用案例做“练习” —让学员自己做案例概念化

9.3 给新咨询师

1. 不要”模仿”案例的每一个细节
 2. 学习案例的“思路” —是怎么想的, 不是”怎么说”
 3. 学习案例的“关键决策” —什么时候做什么
 4. 学习案例的“反移情” —咨询师也是”人”
 5. 学习案例的“边界” —什么能做, 什么不能做
-

十、最后的提醒

案例是临床智慧的载体—不是”作业”的”答案”。案例的“分析”是“临床思维”的示范—不是”思维的标准答案”。案例的“反移情”是“人”的复杂性—不是”咨询师不好”。

愿你从案例中学习临床智慧, 而不是学习”技术”的翻版。

版本: v1.0 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套案例: - 案例 #01: 焦虑 ×2 号助人型 - 案例 #02: 回避 ×5 号观察型 - 案例 #03: 混乱 ×4 号浪漫型 - 案例 #04: 伴侣咨询—焦虑 6 号 × 回避 8 号